

# 2026년 제7차 중증(암)질환심의위원회 사전 검토 보고

## Leadership Brief | 2026.08.17 암질심 사전 점검

| 항목     | 내용                                              |
|--------|-------------------------------------------------|
| 보고일    | 2026년 8월 17일                                    |
| 회의     | 2026년 제7차 중증(암)질환심의위원회                          |
| 회의 예정일 | 2026년 8월 19일                                    |
| 보고 대상  | 보험약가/Market Access Leadership                   |
| 보고 목적  | 7차 암질심 예상 안건, 급여기준 설정 가능성, MSD 관점의 우선 확인 포인트 정리 |

## 1. Executive Snapshot

한 줄 결론: 7차 암질심은 공식 사전 안건이 공개되지 않았지만, D-2 기준 가장 높은 관찰축은 임델트라 재상정 여부다. 퍼제타와 티루캡은 보완자료 제출 신호가 제한적이므로 watchlist에 두되, 결과 발표 전에는 상정 여부와 급여기준 설정 가능성을 확정하지 않는다.

| 핵심 메시지                                                            | Leadership Implication                                                |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 직전 6차 암질심은 림카토와 DCEP에서 급여기준 설정을 인정하고, 퍼제타는 재논의로 남겼다.              | 7차는 재논의·미설정 후보의 보완자료가 실제로 다음 회차에 재진입하는지 확인하는 차수다.                     |
| 임델트라는 소세포암 치료 접근성, 환자·국회 청원, GIFT 이후 급여 공백 이슈가 동시에 부각됐다.          | 상정될 경우 OS 자료 한계와 unmet need 사이에서 암질심이 어떤 조건을 요구하는지가 핵심 read-through다. |
| 퍼제타와 티루캡은 이전 차수에서 재논의 또는 미설정 이력이 있으나 D-2 기준 공개 보완 제출 신호는 강하지 않다.  | 결과표에 포함될 경우 보완자료 수용 수준, 제외될 경우 회사 제출·임상근거·재정영향 병목을 분리해 점검해야 한다.       |
| HIRA의 공식 안건은 사전 공개되지 않으며, 최신 공식 보도자료는 8차 약평위 결과 이후 일반 보도자료만 확인된다. | D+1 리뷰에서는 예상 후보의 상정 여부 자체를 baseline으로 남겨 다음 암질심 예측률을 보정해야 한다.         |

## 2. 직전 6차 암질심 결과 — 이번 회의의 기준선

직전 6차 암질심은 신약 결정신청과 급여기준 확대가 함께 심의된 회차였다. 이번 7차에서는 6차의 재논의 후보와 이전 미설정 후보가 보완자료를 통해 다시 암질심 문턱을 넘는지가 기준선이다.

| 구분         | 약제/영역       | 6차 결과의 의미                           | 7차 연결 해석                                         |
|------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 요양급여 결정신청  | 림카토주        | 재발성/불응성 DLBCL·PMBCL CAR-T에서 급여기준 설정 | 고가·첨단바이오 치료제도 근거와 제도 필요성이 맞으면 설정 가능하다는 신호        |
| 급여기준 확대    | DCEP 병용요법   | 재발성/불응성 다발골수종에서 급여기준 설정             | 기존 regimen 확대는 임상 현장 필요와 표준요법 정합성이 핵심 기준임을 재확인   |
| 재논의        | 퍼제타주        | HER2 양성 조기 유방암 수술 전 보조요법에서 재논의      | 7차 포함 시 보완자료 수용 여부, 제외 시 근거·재정영향 병목이 지속되는지 확인 필요 |
| 미상정/미확인 후보 | 임델트라, 티루캡 등 | 6차 공식 결과표에는 포함되지 않음                 | 7차에서 unmet need 또는 이전 미설정 후보가 실제로 재진입하는지 관찰 필요   |

## 6차 결과에서 7차로 이어지는 세 가지 변화

- ① 재논의 후보의 회차 간 이동 속도 확인 퍼제타는 6차에서 재논의로 남았다. 7차에서 바로 다시 다뤄질 경우 보완자료 제출과 암질심 재검토가 빠르게 작동하는 사례가 되며, 제외될 경우 다음 차수 이상으로 병목이 이월된 것으로 봐야 한다.
- ② 미충족 수요와 생존자료 요구의 긴장 임델트라는 소세포폐암 영역의 치료 공백과 환자 접근성 요구가 강하지만, 공개 보도에서는 OS 자료 한계와 급여기준 설정 기준이 반복적으로 언급된다. 7차 결과는 암질심이 unmet need를 어느 정도까지 근거 불확실성과 균형시키는지 보여줄 수 있다.
- ③ 항암제 급여기준 확대의 재정영향 gate 티루캡과 같은 유방암 표적치료제 후보는 환자군 제한, 바이오마커 기준, 장기 투여 재정영향이 함께 검토될 가능성이 높다. 결과 발표 후에는 설정·미설정 여부보다 급여기준 문구와 제한 조건을 먼저 확인해야 한다.

## 3. 7차 암질심 예상 안건 — Leadership Watchlist

HIRA는 암질심 사전 안건을 공개하지 않는다. 아래 watchlist는 직전 공식 결과, 미설정·재논의 후보 관리 현황, 공개 매체 신호, 환자 접근성 압박, MSD 관련 병용요법 환경을 종합한 사전 점검이다. 최종 안건과 결과는 HIRA 공식 심의결과 발표 이후 확정된다.

### 우선 관찰 후보

| 우선순위 | 약제             | 회사         | 영역             | 현재 판단                                | Leadership 관찰 포인트                                   |
|------|----------------|------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1    | 임델트라           | 암젠코리아      | 소세포폐암          | 재상정 기대 신호가 가장 강한 후보이나 공식 안건 통보는 미확인  | 급여기준 설정 여부, OS 자료 요구 수준, 환자 접근성 압박이 결과 표현에 반영되는지 확인 |
| 2    | 퍼제타주           | 한국로슈       | HER2 양성 조기 유방암 | 6차 재논의 이후 보완 재검토 가능 후보               | 재논의 후 보완자료 수용 여부, 수술 전 보조요법 급여기준 제한 조건 확인           |
| 3    | 티루캡정           | 한국아스트라 제네카 | HR+/HER2- 유방암  | 4차 미설정 이후 재신청 가능성 watch              | 바이오마커·병용요법 기준, 재정영향 관리 조건, 재신청 여부 확인                |
| 4    | 이전 미설정 유방암 후보군 | 복수 회사      | 조기/전이성 유방암     | 공개 재상정 신호는 제한적                       | 장기 투여·보조요법 후보가 암질심에서 요구받는 근거 수준 확인                  |
| 5    | 면역항암 병용요법      | 복수 회사      | 고형암 병용         | 직접 상정 신호는 낮지만 MSD read-through 관찰 필요 | 키트루다 병용 협상·RSA·급여기준 확대 논의에 영향을 줄 수 있는 기준 문구 확인      |

### 후보별 핵심 해석

**임델트라** — 7차의 최우선 재상정 관찰 후보 임델트라는 소세포폐암 치료 공백과 환자 접근성 이슈가 가장 강하게 공개 노출된 후보다. 상정되어 급여기준 설정이 인정되면 GIFT 이후 급여 공백을 줄이는 방향의 정책 신호가 될 수 있다. 반대로 미설정 또는 미상정이면 OS 자료·경제성·급여기준 설계가 여전히 핵심 병목으로 남아 있음을 뜻한다.

**퍼제타** — 재논의 이후 보완자료 수용성 테스트 퍼제타는 직전 6차에서 재논의로 남은 후보이기 때문에, 7차 포함 여부만으로도 보완자료 제출 속도와 암질심 재검토 가능성을 읽을 수 있다. 포함될 경우 HER2 양성 조기 유방암 수술 전 보조요법에서 급여기준 제한 조건과 재정영향 관리 방식이 핵심이다.

**티루캡** — 미설정 후보의 재진입 가능성 watch 티루캡은 이전 미설정 후보군에 속하나 D-2 기준 공개 재신청 신호는 강하지 않다. 결과표에 포함되면 HR+/HER2- 유방암에서 biomarker 기반 표적치료제의 급여기준 설정 문구를 우선 확인해야 한다.

**면역항암 병용요법** — 직접 후보보다 read-through가 중요 이번 7차 암질심에서 키트루다 직접 안건이 확인된 것은 아니지만, 고형암 병용요법의 급여기준 설정·재논의 기준은 파드셉+키트루다 협상 및 향후 MSD 병용요법 전략에 read-through를 줄 수 있다.

## 4. MSD 관점의 주요 영향

| 영역           | 관찰 내용                                           | MSD 대응 관점                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 키트루다/면역항암 병용 | 파드셀+키트루다 협상 지연 환경에서 암질심의 병용요법 기준 문구가 중요         | 결과 발표 후 병용요법 급여기준, 환자군 제한, 가격·RSA read-through를 즉시 분리 점검            |
| 소세포폐암        | 임델트라가 상정될 경우 높은 unmet need와 근거 불확실성의 균형이 드러남    | 폐암 영역에서 OS 자료 요구와 환자 접근성 압박이 급여기준 설정에 미치는 영향 모니터링                   |
| 유방암          | 퍼제타·티루캡 등 보조요법·표적치료제 후보는 장기 투여 재정영향과 환자군 제한이 핵심 | 조기 유방암·HR+/HER2- 영역의 comparator, biomarker, 투여기간 조건을 브랜드 전략 관점에서 추적 |
| 예측 baseline  | D-2 공개 안전 부재로 상정 여부 자체가 가장 중요한 사후 검증 포인트        | D+1에서 상정/미상정, 설정/재논의/미설정, 제외 후보를 분리해 다음 암질심 예측을 보정                  |

## 5. 7차 결과 발표 후 확인해야 할 사항

| 확인 항목                     | 왜 중요한가                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| 임델트라 포함 여부와 급여기준 설정 여부    | 이번 차수의 가장 강한 공개 신호 후보이며, unmet need와 근거 요구의 균형을 보여줌    |
| 퍼제타 재논의 후 재상정 여부          | 직전 차수 재논의 후보가 얼마나 빠르게 보완 후 재검토되는지 확인 가능                |
| 티루캡 또는 다른 이전 미설정 후보 포함 여부 | 미설정 후보의 재신청·재진입 속도와 암질심 보완자료 수용 기준을 파악할 수 있음           |
| 결과 표현의 공식 용어              | 급여기준 설정, 재논의, 급여기준 미설정 차이를 분리해야 후속 약평위·협상 가능성을 오해하지 않음 |
| MSD 관련 병용요법 read-through  | 직접 MSD 안전이 없더라도 병용요법·보조요법 기준 문구가 키트루다 전략에 영향을 줄 수 있음   |

## 6. Source & Caveat

본 보고서는 HIRA 공식 심의결과 공개자료, 직전 암질심·약평위 공개 결과, 내부 누적 reimbursement dataset, 공개 매체 신호 및 하반기 항암제 급여 환경을 바탕으로 작성한 사전 검토 자료다. 암질심 사전 안전은 공식 공개되지 않으므로, 상정 여부·심의결과·후속 약평위 진입 가능성은 HIRA 공식 심의결과 발표 후 D+1 리뷰에서 확인한다.